

Fecha Última Actualización: 19-02-2023 12:24:29

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Regina Del Carmen Paredes Tobar
Edad : 63a 10m 20d
Dirección : Migel Angel 1500 Dpto. Dpto 907

Rut : 7.933.900-8
Fecha Nacto: 30/03/1959
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0529515
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 4164 2223

N° Epicrisis
341991

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Intermedio Quirúrgico

Fecha Ingreso : 17/01/2023 05:38

Días Estadía: 33

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 19/02/2023 12:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

sepsis

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Absceso Perinefritico, Vaciamiento - 18/01/2023 00:00 - Jose Pascual Arenas Kalil
Drenaje Percutáneo O Endoscópico De Hidronefrosis. (Proc.Autónomo) - 18/01/2023 00:00 - Jose Pascual Arenas Kalil
Ureteropielografía Ascendente (Directa) Por Cateterismo Ureteral Uni O Bilateral - 18/01/2023 00:00 - Jose Pascual Arenas Kalil
Pielotomía Exploradora Y/O Terapéutica (Incluye La Pielostomía Y/O Pieloplastía) - 14/02/2023 00:00 - Jose Pascual Arenas Kalil
Flegmón Urinoso, Drenaje Y Cistostomía - 17/02/2023 00:00 - Ricardo Valderrama Gomez

Epidemiología

Resumen Clínico

EGRESO UCI
07/02/2023

Regina Paredes Tobar
7.933.900-8
FI CASR: 17/01/2023
FI UCI: 07/02/2023
FE UCI: 19/02/2023

Antecedentes patológicos personales
·DM2NIR con DOB
·oPie diabético
·Asma
·EPOC
·HTA

Medicación habitual
·Losartán
·Nifedipino
·Metformina
·Salbutamol
·TBQ (+), OH (-), Drogas (-)

Fecha Epicrisis : 19/02/2023 12:24

Página 1 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:52

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Historia clínica

Paciente con los antecedentes descritos, acude a la urgencia de esta institución en donde es diagnosticada de sepsis a foco abdominal: absceso retroperitoneal derecho asociado a cálculo en pelvis renal ipsilateral con fallo orgánico múltiple: fallo metabólico (cetoacidosis diabética), acidosis metabólica, falla renal aguda KDIGO 3, falla hemodinámica, falla respiratoria (EPOC descompensado).

PCR SARS-COV-2 positiva. Inicia corticoides.

En ese contexto se decide manejo quirúrgico ingresando a pabellón el 18/01/23:

- Ureteropielografía retrograda, ascendiendo doble J.
- Lumbotomía derecha
- oDrenaje de colección 150 cc / Cultivos.

Egres a en el postoperatorio inmediato a recuperación anestésica, extubada, requiere reanimación con volumen, se mantiene en falla respiratoria que requiere apoyo mecánico con cánula de alto flujo con buena respuesta, piperacilina tazobactám empíricos, BIC de insulina. Requiere soporte transfusional con 2 unidades de glóbulos rojos.

El 20/01/23 es trasladada al agudo quirúrgico, persiste con requerimiento de CNAF; evoluciona con estabilización y mejoría de falla renal, mejor control glucémico, inicia nutrición enteral; el 21/01 intercorre con atelectasia basal derecha que logra resolverse con kinesioterapia, inicia insulina NPH.

El 22/01 presenta caída de hematocrito (hasta 16) acompañada con taquicardia y nuevos episodios de hiperglucemia, requiere nuevo soporte transfusional.

Se realiza AngioTC que revela disminución de colecciones por lo que se retira un drenaje.

El 27/01 se de escala tratamiento antibiótico a Ceftriaxona/Clindamicina, sin rescate microbiológico a excepción de candida en urocultivo que se interpreta como sin significado clínico. El 28/01 evoluciona con aumento de parámetros inflamatorios y episodios de hipoglucemia, se suspende NPH. Egres a sala de menor complejidad.

El 31/01/23 presenta cuadro clínico compatible con descarga séptica, se toman cultivos, inicia vancomicina e Imipenem, el 01/02/23 se rescata routella plantícola NDM en ambos hemocultivos, inicia ceftazidima ¿ avibactam más aztreonam; se realiza TC de abdomen y pelvis que revela:

- Resolución del absceso pararenal posterior. Persistencia de pequeños abscesos adyacentes al segmento posterior del LHD.
- Atrofia renal derecha. Cálculo coraliforme en la pelvis renal derecha. Catéter doble J derecho bien posicionado.
- Foco de relleno alveolar en el LS derecho.

El 03/02/23 se retiran drenajes.

El 04/02 intercorre con hemorragia digestiva alta con compromiso hemodinámico, requiere soporte transfusional e inhibidores de la bomba de protones, se traslada el 05/02 nuevamente a agudo quirúrgico y se realiza endoscopia digestiva alta que revela ulcera Forrest II-B en bulbo que se trata con inyecta terapia.

El 06/02/2023 intercorre con falla respiratoria hipoxémica, acidosis metabólica, hipotensión arterial, desaturación requiere apoyo escalonado con oxígeno suplementario, luego cánula de alto flujo con mala respuesta, despuesta ventilación mecánica no invasiva, hasta que el 07/02/23 en horas de la madrugada requiere intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica; sedación profunda, mantienen mismo esquema antibiótico, administran bicarbonato de sodio y reanimación con cristaloides y albumina.

Evolución en UCI

HDN: inestable a su inicio, tras medidas de reanimación se logra destetar de DVA con buena tolerancia. Mantiene durante su estancia Hb <7 que requiere transfusión esporádica de GR. Dado sepsis, requiere apoyo intermienten con DVA. Tras ingreso a pabellón, presenta shock hipovolémico que requiere apoyo con GR (3 Unidades) y reanimación con volumen y doble DVA, que se logra estabilizar a las 36hrs. Presenta nuevo quiebre hemodinámico secundario a sepsis abdominal, que no logra responder a uso de DVA con NAD a 0.8mcg/kg/min, Adrenalina 0.3mcg/kg/min ni volumen.

Fecha Última Actualización: 19-02-2023 12:24:29

Página 3 de 4

RESP: inicialmente con SDRA sec a sepsis, con conexión a VMI con lo que mejora oxemia. Se mantiene en VMI durante toda su estancia. Con intercorrientes, presenta nuevos eventos de SDRA secundarios a shock, tanto hipovolémico como distributivo, sin presentar mejoría a pesar de medidas de corrección.

Qx: Calculo colariforme que requiere drenaje y pigtail. Ingres a pabellón el 14.02 para resolución definitiva, sin embargo, presenta shock hipovolémico durante disección de ureter derecho. Dado inestabilidad, sin posibilidad de nuevo ingreso a pabellón para resolución de shock.

Inflamatorio: Se mantiene en tto con Ceftazidima/Avibactam + Aztreonam por Raoultella ssp NDM durante toda su estancia en UPC. Tras cultivos intraoperatorios, se debe agregar Anidulafungina + Vancomicina por C.Albicans y Staph Hominis en cultivos, sin respuesta a tto tras 72hrs de terapia full.

Renal: cursa con falla renal secundaria a shock, con requerimientos de TRR

Nutricional: reg enteral regularmente tolerado asociado a hiperglicemias. En reg 0 tras shock.

Evolución tórpida durante las ultimas 24 hrs, sin respuesta terapia médica full. Se conversa caso con jefatura de módulo, se declara a paciente fuera de alcance médico. Se instauran medidas para buen morir. Se avsa a familiares. Pcte fallece a las del 19.02.2023. Se emite certificado de defunción.

Diagnósticos de Egreso:

- 1.Shock séptico de foco abdominal
 - a.Absceso retroperitoneal derecho asociado a cálculo en pelvis renal ipsilateral operado (18-01-23)
 - b. Sepsis abdominal por C.Albicans y Staph Hominis refractario a tto
2. Shock Hipovolémico resuelto
 - a) Tansfusión 3UGR, 7U PFC y 7U Crioprecipitado
- 3.SDOM: Renal, HDN Respiratorio, CID
- 4.AKI KDIGO 3 oligúrica
 - a.Inicio TRR 13/02
- 5.CAD resuelta
- 6.COVID-19 (+) recuperado
7. Transfusión multiple
 - a. GR total: 19 U
 - b- PFC total: 7U
 - c. Crioprecipitado total: 7U
- 8.Antecedentes: DM2NIR con DOB, Pie diabético, Asma, EPOC, HTA

Diagnóstico de Egreso

- Choque séptico - 1.Shock séptico de foco abdominal
- a.Absceso retroperitoneal derecho asociado a cálculo en pelvis renal ipsilateral operado (18-01-23)
 - b. Sepsis abdominal por C.Albicans y Staph Hominis refractario a tto
2. Shock Hipovolémico resuelto
- a) Tansfusión 3UGR, 7U PFC y 7U Crioprecipitado
- 3.SDOM: Renal, HDN Respiratorio, CID
- 4.AKI KDIGO 3 oligúrica
- a.Inicio TRR 13/02
- 5.CAD resuelta
- 6.COVID-19 (+) recuperado
7. Transfusión multiple
- a. GR total: 19 U
 - b- PFC total: 7U
 - c. Crioprecipitado total: 7U
- 8.Antecedentes: DM2NIR con DOB, Pie diabético, Asma, EPOC, HTA

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Fecha Epicrisis : 19/02/2023 12:24

Página 3 de 4

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:52

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

fallecido

Plan Post Alta

fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Gonzalo Núñez Muñoz
Médico Tratante (Staff)